

Infecciones durante el embarazo (TORCH, VIH, sífilis, etc.)

1. Introducción y relevancia clínica

Durante el embarazo, la mujer atraviesa un estado de **inmunomodulación fisiológica**, lo que la hace más susceptible a infecciones o a formas más graves de ellas.

Muchas infecciones maternas pueden transmitirse al feto o al recién nacido, provocando:

- Muerte fetal intrauterina.
- Aborto espontáneo.
- Malformaciones congénitas.
- Prematurez o bajo peso al nacer.

El grupo de infecciones clásicamente estudiado bajo el acrónimo **TORCH** comprende:

Toxoplasmosis
Otras (sífilis, VIH, varicela, parvovirus B19, hepatitis)
Rubéola
Citomegalovirus (CMV)
Herpes simple

Estas infecciones son relevantes no solo desde el punto de vista clínico, sino también **epidemiológico y preventivo**, ya que muchas son **detectables mediante tamizaje prenatal** y **prevenibles mediante inmunización o medidas higiénico-sanitarias**.

2. Fisiopatología general: transmisión vertical

La transmisión puede ocurrir por tres vías principales:

Vía	Ejemplo
Transplacentaria (hematógica)	Rubéola, CMV, toxoplasmosis, sífilis

Durante el parto (canal del parto) VIH, herpes simple, hepatitis B

Postnatal (lactancia o contacto) VIH, CMV, varicela

El daño fetal depende de:

- Edad gestacional al momento de la infección.
- Virulencia y tropismo del agente.
- Inmunidad materna previa.

□ Las infecciones en el **primer trimestre** tienden a causar **malformaciones congénitas**, mientras que en el **tercer trimestre** producen **infecciones sistémicas o parto prematuro**.

3. Principales infecciones y su manejo

A. Toxoplasmosis

Agente: *Toxoplasma gondii* (protozoo).

Vía de transmisión: ingestión de carne cruda o contacto con heces de gato infectado.

Riesgo fetal:

- Mayor **probabilidad de transmisión en tercer trimestre (60%)**, pero **daño más severo si infección en primer trimestre**.

Manifestaciones fetales:

- Aborto o muerte fetal.
- **Triada clásica:** coriorretinitis + hidrocefalia + calcificaciones intracraneanas.

Diagnóstico:

- Serología: IgM positiva o seroconversión de IgG.

- PCR en líquido amniótico si sospecha fetal.

Tratamiento (MINSAL / OMS):

- **<18 semanas:** *Espiramicina* 1 g cada 8 h (reduce transmisión placentaria).
- **≥18 semanas o infección confirmada fetal:** *Pirimetamina* + *sulfadiazina* + *ácido folínico*.

Prevención:

- Evitar carnes crudas, lavar frutas/verduras, higiene con gatos.
-

B. Rubéola

Agente: Virus de la rubéola (togavirus).

Vía: Transplacentaria.

Riesgo fetal:

- Máximo si infección materna <12 semanas (85% de riesgo de síndrome congénito).
- Disminuye después de las 20 s (<1%).

Síndrome de rubéola congénita:

- **Triada clásica:** cataratas, sordera neurosensorial, cardiopatía congénita (ductus persistente o estenosis pulmonar).
- Además: microcefalia, hepatoesplenomegalia, púrpura.

Diagnóstico:

- Serología (IgM o seroconversión de IgG).
- PCR viral.

Manejo:

- No hay tratamiento específico.

- Infección antes de las 12 s → se debe ofrecer **interrupción del embarazo** por riesgo teratogénico severo.

Prevención:

- **Vacuna triple viral (SRP)** antes del embarazo.
 - Contraindicado vacunar durante la gestación (virus vivo atenuado).
-

C. Citomegalovirus (CMV)

Agente: CMV (herpesvirus tipo 5).

Vía: Transplacentaria, canal del parto o lactancia.

Riesgo fetal:

- Infección primaria materna → 40% transmisión, 10% sintomáticos.

Manifestaciones fetales:

- Microcefalia, calcificaciones periventriculares, hipoacusia, RCIU, hepatoesplenomegalia.

Diagnóstico:

- IgM positiva o seroconversión.
- PCR en orina o saliva del RN.
- Ecografía: ventriculomegalia, hepatoesplenomegalia, calcificaciones.

Tratamiento:

- No hay terapia aprobada durante el embarazo.
- En RN sintomático: ganciclovir o valganciclovir (mejora hipoacusia).

Prevención:

- Lavado de manos, evitar contacto con secreciones infantiles.

D. Herpes simple (VHS-1 y 2)

Vía: Contacto directo con lesiones, transmisión intraparto o transplacentaria.

Riesgo:

- Mayor si infección primaria al final del embarazo.

Manifestaciones neonatales:

- Encefalitis, lesiones vesiculares diseminadas, sepsis neonatal.

Diagnóstico:

- PCR de lesiones o LCR.

Manejo:

- **Acyclovir 400 mg cada 8 h** desde la semana 36 hasta el parto (profilaxis).
- **Cesárea** si hay lesiones activas o pródromos al inicio del trabajo de parto.
- Tratamiento neonatal: **Acyclovir IV 20 mg/kg cada 8 h** por 14–21 días.

E. Sífilis

Agente: *Treponema pallidum*.

Vía: Transplacentaria (en cualquier trimestre).

Diagnóstico:

- Tamizaje obligatorio (VDRL o RPR) en **primer control y al tercer trimestre**.
- Confirmación con FTA-Abs o TPHA.

Manifestaciones:

- Aborto espontáneo, muerte fetal.

- Sífilis congénita: rinitis serosanguinolenta, lesiones cutáneas, hepatomegalia, anemia, malformaciones óseas.

Tratamiento (MINSAL 2023):

- **Penicilina benzatina 2,4 millones UI IM semanal × 3 semanas.**
- Si alergia → desensibilización y penicilina (único efectivo en feto).

□ Todo recién nacido de madre tratada <4 semanas antes del parto debe recibir penicilina benzatina profiláctica.

F. VIH

Transmisión vertical:

- Sin tratamiento: 15–45%.
- Con terapia antirretroviral (TARV): <2%.

Diagnóstico:

- Test ELISA en primer control y repetir al tercer trimestre.

Tratamiento:

- TARV triple desde el diagnóstico (según esquema nacional MINSAL).
 - Si carga viral >1.000 copias/mL → cesárea electiva a las 38 s.
 - Profilaxis neonatal: **Zidovudina 4 mg/kg/día por 4 semanas.**
 - **Lactancia materna contraindicada** (en Chile).
-

G. Hepatitis B

Riesgo de transmisión:

- 90% si madre HBsAg y HBeAg positiva.

Prevención:

- **Inmunoglobulina anti-HBs + vacuna HBV** al RN dentro de las 12 horas postparto.
 - No contraindica lactancia.
 - No hay indicación de cesárea electiva solo por hepatitis B.
-

H. Varicela zóster

Riesgo fetal:

- Mayor si infección entre 8–20 semanas → síndrome de varicela congénita:
 - Cicatrices cutáneas, hipoplasia de extremidades, microftalmia, RCIU.

Prevención:

- Vacuna antes del embarazo (virus vivo, contraindicado durante gestación).
 - Exposición en embarazada susceptible → **inmunoglobulina específica anti-VZV**.
 - Tratamiento materno: **Acyclovir VO o IV** según gravedad.
-

I. Parvovirus B19

Efecto fetal:

- Anemia severa, hidrops fetal, muerte fetal.

Diagnóstico:

- IgM positiva o PCR.
- Ecografía con Doppler (signos de hidrops).

Manejo:

- Transfusión intrauterina en casos severos.

4. Diagnóstico prenatal y ecográfico

El seguimiento fetal incluye:

- **Ecografía seriada:** RCIU, microcefalia, hepatoesplenomegalia, calcificaciones, hidrops.
 - **Amniocentesis con PCR viral o parasitaria.**
 - **Monitorización del bienestar fetal** desde las 28 s si infección activa.
-

5. Prevención (según MINSAL)

Infección	Prevención
Rubéola	Vacuna SRP pregestacional
Toxoplasmosis	Higiene alimentaria y evitar gatos
VIH	TARV en madre y RN, cesárea si carga viral alta
Hepatitis B	Vacuna universal RN + inmunoglobulina
Sífilis	Tamizaje y penicilina precoz
Herpes	Acyclovir desde 36 s, cesárea si lesiones
CMV	Lavado de manos, evitar contacto con saliva/flujo de niños

Varicela Vacuna pregestacional, inmunoglobulina post exposición

6. Complicaciones perinatales

Maternas	Fetales/neonatales
Corioamnionitis	RCIU, parto prematuro
Sepsis	Infección congénita
Preeclampsia	Muerte intrauterina
Rotura prematura de membranas	Malformaciones, sordera, ceguera
Aborto	Hidrops fetal

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. TORCH: *Toxoplasma, Otras, Rubéola, CMV, Herpes*.
2. **Triada toxoplasmosis:** coriorretinitis + hidrocefalia + calcificaciones.
3. **Triada rubéola:** cataratas + sordera + cardiopatía.
4. **Sífilis:** VDRL positivo → penicilina benzatina siempre.

5. **VIH:** TARV materna + cesárea + evitar lactancia.
6. **CMV:** microcefalia y calcificaciones periventriculares.
7. **Varicela:** inmunoglobulina específica si exposición en embarazada no inmune.



Errores comunes

- Usar vacuna triple viral durante el embarazo.
- No tratar sífilis por alergia (único fármaco útil: penicilina).
- No administrar profilaxis neonatal para hepatitis B.
- Ignorar importancia de TARV completa en VIH positivo.
- No diferenciar calcificaciones periventriculares (CMV) vs difusas (toxoplasma).

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **TORCH** agrupa infecciones con transmisión vertical y potencial teratogénico.
2. **Toxoplasmosis:** espiramicina o pirimetamina según edad gestacional.
3. **Rubéola:** vacunación pregestacional; infección precoz = interrupción.
4. **Sífilis:** tamizaje universal y tratamiento con penicilina benzatina.
5. **VIH:** TARV triple, cesárea si carga viral >1.000 copias, sin lactancia.
6. **Hepatitis B:** inmunoglobulina + vacuna al RN en primeras 12 h.
7. **Herpes:** aciclovir profiláctico desde 36 s, cesárea si lesiones activas.